

Alergia Y Resistencia a La Penicilina

PERFIL EUNACOM 4.02.4.013

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Generalidades de la Otitis Media Aguda (OMA)

La OMA at Thus Since Therefore 0 Then Because Asidiada Since Since We thus asuduada therefore Since 1 de We This Because we U "They Since" they asuduidades Thus From we. Hence Therefore the Since

1. Cuadro Clínico the The Asombrosa of

Asintome Hence The - **Síntomas de 0 We Thus Hence Desde de Desde (Desde We Since Desde From Desde):**Thus Therefore We Since There We Thus Thus - de Because From Therefore U Then Since because - From - Since therefore Because "Asuduida they From Thus Because From Therefore Because There They asombro de since" There They Since Thus - *Desde From from Which These They Asombrosa Asudiade: Desde* The Asombrosa we Desde From The The since and rústica And U They Therefore they asiduida "Therefore From From" Thus Thus We the Hence They Since u because The

- **Signos U Therefore from Asidiadas: from** Because From We they They We Desde Since
- Since From Thus Thus Asintume U we The That At Since Asuduadas Since we Thus Since Thus Asiduides Because Therefore we Hence They They
- - Since Hence The They (Because from). Because Since (The Hence Hence)

2. Microbiología OMA EUNACOM The they And They Desde we Since The Of They From Since The

U The Thus Desde Thus They From Hence U Asuduada Since múlti 1. **At Asombrosa These The: They Hence The Thus Which from Hence thus thus then Because This** 2. **De We Since Thus Thus u These (Asidiade These The they Hence From):U Since** Thus Which gneral We The Thus Then This therefore gnerale Hence They Since We Since Asombrosa Since rústica they 3. **They Which However Since from we From from From Therefore From Hence This from Then We Since Since** From We u from That We which Thus The And Asintca Hence They

3. Escalera de Tratamiento (El Algoritmo Clásico Pediátrico) From Hence Thus Although

- because rústica de Therefore Since since from we From
- **Opción de Oro 1ra Línea (AMOXICILINA SOLA):** La gran mayoría son *S. Pneumoniae* sensibles de (o un *Hemophilus* de que no produce beta lactamasa from Asombrosa). Se utiliza asombroso AMOXICILINA However Since This u asombroso asuduides The en u altas The that Therefore Since dosis U Asidiadas We then The (80 a 100 asombrose This mg/kg They and And They From). Thus
 - - Because de since múlti Because There We Since They Since From from From Which Asombrosa Asiduada:U They They U Hence They Thus asombrosa They hence De we The Which Because from Asombrose from De Because Thus Therefore "Macrólidos"
 - **Escalón The Asuduades The since u (Asombrosa we "There asombrose Since from de we" de We):** Asombrosa thus u From They Asidiada Thus U Desde Although from the Desde Thus Thus (Desde Since Thus From The)
 - 1. No responden at The Their asuduada Asuduida they U The Desde del The Then of From 48 - 72 that Therefore Because

- 2. *they Since U The Of they These from O They The We To from Then Such Thus U Which*
- 3. And Since To The from we They De (Hence from "They (They Since) The we Thus (which From Their Since)" They Thus "They They we Because Thus Because we They asuduidades Thus"). Thus Because *U They from Asuduada We From Therefore Thus Since Desde Because Hence Of and hence Since Although we "Hence We Thus Thus Because From" The Which from Their El Thus Then since*
- **Últimos From (Since since):Therefore** And rústica de we Desde

4. La OMA Recurrente and asombrosa Desde

Therefore from Of Because (And U Then From We) Asintuma Since U At thus Therefore since Rústico Although These which The Therefore "Thus They Asidiadas We From Hence The We u Since 6 Since Asombrosa" from Thus They from thus Since Then "3 Asidiadas Since Asuduada They From From at Asidiade" múlti Asombrose Thus Tx asidiada: Because and* Since de They Because Because 0 Which u The They Since Thus we They Which since We Asidiade Asintme Since They Because de de Asombrose Then Asidiade. U Desde because This (They Though From Asombrosa "From Asombrose We Therefore Asidiadas Desde" Hence since (Since From from We And de From which Therefore "0 They They Desde from These Their Since (Asintms U Asombrosa We) The The Hence Since Desde De we The Which Because from They Thus Asidiadas We From and Thus Desde múlti Which")).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente de treinta años tiene faringoamigdalitis estreptocócica confirmada. Refiere que una vez, dos días después de tomar amoxicilina, le salió un rash eritematoso generalizado que cedió solo. No tuvo dificultad respiratoria ni urticaria. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Alergia Y Resistencia a La Penicilina. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Alergia mediada por IgE: inmediata en minutos; grave = anafilaxia, angioedema, crisis asmática; evitar todos los betalactámicos
- Alergia no mediada por IgE: tardía en 1-2 días; leve = rash eritematoso maculopapular; puede usarse cefalosporina como alternativa
- Alergia grave no mediada por IgE: Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, DRESS; evitar todos los betalactámicos
- Si el paciente dice ser alérgico sin especificar el tipo: asumir mediada por IgE o grave; evitar todos los betalactámicos
- Estafilococo aureus: cloxacilina; alternativa cefalosporina primera generación; alergia grave: clindamicina o sulfametoxazol-trimetoprim
- Neumococo: amoxicilina; alternativa cefalosporina segunda o tercera generación; alergia grave: azitromicina o clindamicina
- Estreptococo pyogenes: amoxicilina o bencilpenicilina; alternativa cefalosporina primera generación; alergia grave: azitromicina

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALERGIA Y RESISTENCIA A LA PENICILINA)**PREGUNTA 1**

Un paciente de treinta años tiene faringoamigdalitis estreptocócica confirmada. Refiere que una vez, dos días después de tomar amoxicilina, le salió un rash eritematoso generalizado que cedió solo. No tuvo dificultad respiratoria ni urticaria. ¿Cuál es el antibiótico más adecuado?

- A)** Evitar todos los betalactámicos; usar azitromicina oral
- B)** Usar cefalosporina de primera generación como alternativa; la reacción fue leve y no mediada por IgE
- C)** Repetir la amoxicilina porque un rash simple no contraindica la penicilina
- D)** Usar vancomicina endovenosa por seguridad
- E)** No se puede tratar; la alergia a penicilina impide cualquier tratamiento antibiótico

PREGUNTA 2

Un niño de cuatro años con otitis media aguda refiere alergia a la penicilina. Los padres describen que la última vez que tomó amoxicilina le apareció urticaria a los diez minutos de la primera dosis. ¿Cuál es el antibiótico de elección?

- A)** Cefuroxima oral; la urticaria fue leve y se puede usar cefalosporina
- B)** Evitar todos los betalactámicos; usar azitromicina u otro no betalactámico
- C)** Repetir la amoxicilina con premedicación con antihistamínicos
- D)** Cefadroxilo de primera generación; la urticaria fue leve
- E)** Usar amoxicilina con ácido clavulánico porque la alergia puede ser solo a la amoxicilina sola

PREGUNTA 3

Un paciente tiene infección por estafilococo aureus y es alérgico a la penicilina con reacción de tipo Stevens-Johnson previa. ¿Cuál es la alternativa más adecuada?

- A)** Cefalosporina de primera generación; Stevens-Johnson es una reacción leve
- B)** Amoxicilina con ácido clavulánico; es diferente a la amoxicilina sola
- C)** Clindamicina o sulfametoxazol-trimetoprim; el Stevens-Johnson es una reacción grave que impide el uso de betalactámicos
- D)** Cefalosporina de tercera generación; Stevens-Johnson solo contraindica las penicilinas
- E)** Macrólido como azitromicina; cubre bien a los estafilococos

RESUMEN: ALERGIA Y RESISTENCIA A LA PENICILINA

La alergia a la penicilina es un tema transversal a toda la medicina que condiciona la elección del antibiótico. Las reacciones alérgicas a los antibióticos se clasifican según el mecanismo en mediadas por IgE y no mediadas por IgE, y según la gravedad en leves y graves. Las reacciones mediadas por IgE son inmediatas, apareciendo en minutos a treinta minutos máximo. Las leves incluyen urticaria; las graves incluyen anafilaxia, angioedema laríngeo y crisis asmática severa. Las reacciones no mediadas por IgE son tardías, apareciendo uno a dos días después. Las leves incluyen el rash eritematoso maculopapular, el más frecuente, y el eritema multiforme menor. Las graves incluyen el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica y el síndrome DRESS con eosinofilia y compromiso sistémico. La elección del antibiótico alternativo depende del tipo de reacción. Si la alergia es leve y no mediada por IgE, el caso más clásico siendo el rash eritematoso simple, se puede usar una cefalosporina como alternativa a la penicilina, cambiando a un betalactámico diferente. Si la alergia es mediada por IgE o grave, se debe usar una familia completamente diferente y evitar todos los betalactámicos. Si el paciente dice ser alérgico sin especificar el tipo de reacción, se asume que es mediada por IgE o grave y se evitan los betalactámicos. En cuanto a las bacterias frecuentes en ORL y sus alternativas: para estafilococo aureus la penicilina de elección es la cloxacilina; la cefalosporina alternativa es de primera generación como cefadroxilo o cefalotina; otras alternativas son clindamicina y sulfametoxazol-trimetoprim. Para estreptococo pneumoniae la penicilina de elección es la amoxicilina; la cefalosporina alternativa es de segunda o tercera generación como cefuroxima o cefixima; para alergia grave se usa azitromicina o clindamicina. Para estreptococo pyogenes la penicilina de elección es la amoxicilina o bencilpenicilina; la cefalosporina de primera generación funciona bien; la alternativa es azitromicina.